

FIEVRE BOUTONNEUSE MEDITERRANEEENNE

DR .A.DEHIMI
MALADIES INFECTIEUSES
CHUC

INTRODUCTION

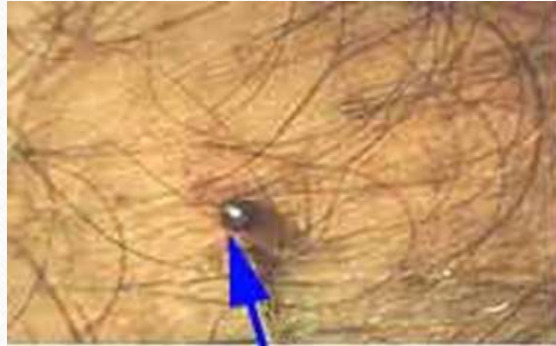
- La **fièvre boutonneuse méditerranéenne (FBM)** fait partie des maladies vectorielles à tiques. C'est l'infection par une bactérie de la famille des rickettsies : *Rickettsia conorii* et transmise par la tique du chien *Rhipicephalus sanguineus*.
- Connue sous d'autres noms (), elle est présente sur le littoral méditerranéen, où elle sévit surtout en été (Mai-Octobre). Mais le tourisme et les transports modernes font que des cas peuvent survenir ailleurs (retours de voyage). Elle serait en extension géographique, et de gravité croissante. Elle est considérée comme une maladie émergente ou plutôt réémergente¹.

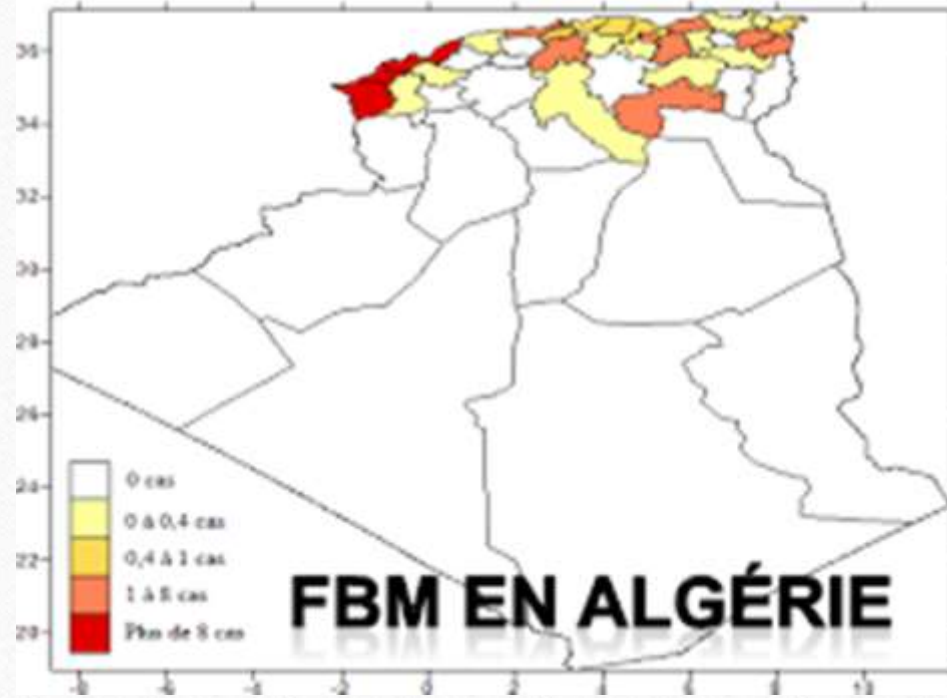
HISTORIQUE

- En 1910, Conor et Brück décrivent sous le nom de « fièvre boutonneuse » une maladie éruptive bénigne qu'ils observaient à Tunis depuis quelques années, et qu'ils tenaient comme une curiosité de la région. Dans les années qui suivent, les descriptions analogues se multiplient sur le littoral méditerranéen.
- D'où des dizaines d'appellations telles que : fièvre arthro-myalgique, fièvre exanthématique d'été, fièvre escarro-nodulaire, fièvre de Marseille ou d'Olmer, typhus endémique d'été, typhus bénin, typhus des vendanges, fièvre typho-exanthématique, maladie de Carducci, etc.

AGENT CAUSAL

- Agent causal
- *Rickettsia conorii* : cocco-bacille (Gram négatif faible), intracellulaire strict
- Transmission
 - - Maladie vectorielle
 - - Par la tique du chien (*Rhipicephalus sanguineus*)
 - - Fréquente dans le pourtour méditerranéen, en période estivale (mai-octobre)





PATHOGENIE

- Après **inoculation** par la **tique**, la bactérie pénètre dans les cellules endothéliales des petits vaisseaux où elle se multiplie → **vascularite, thrombose, purpura** et **bactériémie** (atteintes viscérales). (tache noire de piéri)
- La pique infectante n'est pas le fait de la forme adulte, mais des formes immatures (**larve, nymphe**). Leur piqure est le plus souvent **indolore**, passant inaperçue, d'autant plus que les tiques immatures sont à la limite de la visibilité⁴. La tique doit rester de **10 à 20 h** sur la peau pour être **contaminante**.

TABLEAU CLINIQUE

- - Piquêre indolore
- - Incubation : 6-7 jours
- - J7 : **fièvre**, céphalées, algies diffuses
- La **tache noire** (ou rouge) = escarre d'inoculation ; parfois conjonctivite
- - Phase d'état : au tableau précédent s'ajoute une **éruption maculo-papuleuse** avec parfois un relief (**boutonneuse**), d'intensité variable généralisée et atteignant les paumes et plantes. Purpura possible (grave)

-
- **Signes neuro-méningés** : méningite, encéphalite
 - **Signes cardio-vasculaires** : myocardite
 - **Autres** : pneumopathie atypique, IRA, hémorragies digestives; HSPM
 - Ces formes sévères représentent 5 à 6 % des cas. Elles sont associées à des facteurs de risques : alcoolisme, diabète, déficit en G6PD, âge avancé, retard de traitement ou antibiothérapie non adaptée³.
 - **L'évolution est favorable en général sous traitement pendant 10j.**

Fièvre boutonneuse méditerranéenne
tache noire





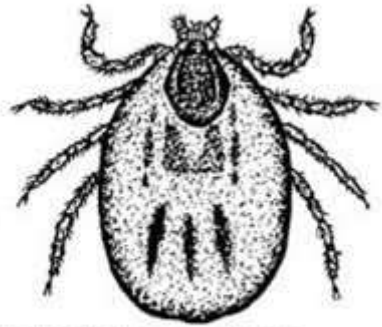
DIAGNOSTIC

- - Orientation épidémioclinique (fièvre, tache noire, saison)
- - **Indirect +++** : **sérologie** positive qu 'après 30j
- (2 sérums à 10j d 'intervalle)
- - **Direct** : à partir de sang ou de biopsie cutanée
- en laboratoire spécialisé.
- - Hyperleucocytose (PNN), CRP+/VS+,

TRAITEMENT

Antibiothérapie : **doxycycline** : 200 mg/j; 5-7 j
 fluoroquinolone : 5 j); si allergie
Enfant/Grossesse: **josamycine** (50 mg/kg/j); 8 j

- **Prévention:**
- - Éviter la piqûre de tique
- - Enlever la tique le plus vite possible (il faut au moins 20h d'attachement pour la transmission)



Rhipicephalus sanguineus
vecteur de la fièvre boutonneuse

**MERCI
DE
VOTRE
ATTENTION**



Figure 6 - *Rhipicephalus sanguineus*, larve de Dekari.